

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre:	ADER MANUEL	Número de documento:	45683086	Estado Civil:	
Tipo de documento:	D.N.I.	Edad de Atención:	22 años 3 meses	Sexo:	Masculino
Fecha de nacimiento:	26/04/2004	Dirección de domicilio:	AV. CABILDO 645 5° A	Teléfono domicilio:	1149865834
Lugar de residencia:	CABA	Parentesco:	Madre	Teléfono acompañante:	1149865834
Acompañante:	mejalelaty alejandra	Plan:	CELESTE	Numero de afiliado:	10097779003
Aseguradora:	MEDICUS	Episodio:	45137959	Clase de episodio:	Internados
Lugar de Atención:	HB Central				

Fecha Ingreso: 05/08/2026

Fecha Egreso: 05/08/2026

Epicrisis de egreso hospitalario

Condición de Egreso: Domicilio sin At. Domiciliaria

Antecedentes personales:

HEMATOLOGIA
Consultorio

SMD IPSS-Mol RA que recae como LMA FLT3+ a 100 días post haploSCT Tratamientos post trasplante:

1L Dosis intermedias de ARA-C + midostaurina. Rta: Refractario

2L AZA-VEN-Gilteritinib ciclo x 1. Rta: refractario con carga alélica de FLT3 en aumento R 0.9

C2: Día 14 -----2,7% blastos.

C2: Día 26 (16/07):-----5.8% Blastos mieloides sin recuperación HP con alta carga transfusional y neutropenia muy severa

Intercurrencias recientes:

13/07: MIOPERICARDITIS IDIOPÁTICA EN CONTEXTO DE NEUTROPENIA FEBRIL: buena evolución con ibuprofeno, colchicina + meprednisona 40 mg día. Debido al cuadro cardíaco actual, con imposibilidad de proceder a trasplante en lo inmediato se canceló el WU que tenía fecha de colecta para el 2/08. Se informó a asesoría de INCUCAI Dra. Formisano.

En la fecha acude a control.

DÍA + 42 POST C2 AZA-VEN-GILTE

Asintomático.

Coulter: Hb 8,4 gr/dL, GB 2800/mm3, plaq 47.000/mm3 (última transfusión 24/07)

FSP:

Se habla con el paciente y sus padres Alejandra y Pablo de la refractariedad al tratamiento a pesar de mejoría de hemograma

Paciente y familia realizaron múltiples consultas inetrnacionales vía mail por su cuenta. Están muy interesados en ingresar a un ensayo clínico que contemple terapia CART o biespecífico CD3-FLT3.

El día 24 de julio me escribió el Dr. Short médico jefe de departamento de medicina traslasional y trials Fase I y II. No considera al paciente candidato a ensayo clínico fase I sin que haya recibido quirzatinib.

Se plantea nueva PAMO 3/08 para reevaluar si es posible reiniciar gilteritinib 120 mg día monodroga si la MO no está masivamente infiltrada.

El paciente presenta miopericarditis con evolución favorable pero reciente. El Dr. Rojas, cardiólogo a cargo del caso fue claro en las posibilidades de complicaciones severas cardíológicas de iniciar tratamientos inflamatorios.

Motivo de internación:

Puncion aspirativa de medula osea

Resumen de Internación:

Paciente ingresa de forma programada para realizar PAMO.

Se realiza procedimiento con buena tolerancia.

Egreso hospitalario y control ambulatorio.

Comentarios

Pautas de alarma

Se brindan pautas de alarma y educación acorde a diagnostico

Responsable: STEMMELIN CAMILA

No. Matrícula MN180814

Servicio: HEMATOLOGIA

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre: ADER MANUEL

Tipo de documento: D.N.I.

Lugar de atención: HB Central

Número de documento: 45683086

Episodio: 45137959

Fecha de nacimiento: 26/04/2004

Clase de episodio: Internados



HOSPITAL BRITÁNICO
DR. CAMILA STEMMELIN
MIR. 180.814
HEMATOLOGÍA